

Varicela y herpes zóster

Varicela del adulto: siempre se trata · Zóster: las 72 horas, el compromiso oftálmico y la neuralgia postherpética · Vacunación y aislamiento

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección IV (Infectología ambulatoria)

Glosario de siglas: VVZ: virus varicela-zóster · NPH: neuralgia postherpética · HZO: herpes zóster oftálmico · SNC: sistema nervioso central · LCR: líquido cefalorraquídeo · PCR: reacción en cadena de la polimerasa · IGVZ: inmunoglobulina específica anti-varicela-zóster · TPH: trasplante de precursores hematopoyéticos · PNI: Programa Nacional de Inmunizaciones · MINSAL: Ministerio de Salud de Chile · SIRI: síndrome inflamatorio de reconstitución inmune.

Alcance y fuentes. Basado en las recomendaciones del ACIP/CDC sobre vacunas contra varicela y zóster, las guías IDSA y la literatura de referencia (Gnann y Whitley, *N Engl J Med*), los ensayos ZOE-50 y ZOE-70 de la vacuna recombinante adyuvada, y las normas de aislamiento del CDC/HICPAC. **La disponibilidad y las indicaciones de las vacunas en Chile deben verificarse en el calendario vigente del Programa Nacional de Inmunizaciones.**

Índice

1. Un virus, dos enfermedades
2. Varicela: epidemiología y clínica
3. Varicela del adulto y complicaciones
4. Diagnóstico de la varicela
5. Tratamiento de la varicela
6. Varicela en el embarazo y varicela neonatal
7. Profilaxis postexposición de la varicela
8. Herpes zóster: patogenia y factores de riesgo
9. Herpes zóster: clínica
10. Formas especiales de zóster
11. Diagnóstico del zóster
12. Tratamiento del zóster
13. Neuralgia postherpética
14. Zóster en el inmunosuprimido
15. Aislamiento y control de infecciones
16. Vacunación
17. Errores frecuentes
18. Perlas de alto rendimiento
19. Bibliografía esencial

1. Un virus, dos enfermedades

El **virus varicela-zóster** (herpesvirus humano 3) produce dos cuadros clínicos distintos:

```
PRIMOINFECCIÓN -> VARICELA (exantema generalizado)
                    |
                    El virus asciende por los nervios sensitivos
                    y establece LATENCIA en los ganglios de las
                    raíces dorsales y de los pares craneales
                    |
                    Caída de la inmunidad celular específica
                    |
REACTIVACIÓN      -> HERPES ZÓSTER (erupción dermatómica)
```

Consecuencia epidemiológica que se olvida: una persona con **herpes zóster puede transmitir el virus y causar VARICELA** (no zóster) en un susceptible, por contacto con el líquido de las vesículas. Por eso el zóster requiere precauciones, y por eso una embarazada susceptible expuesta a un zóster está en riesgo.

2. Varicela: epidemiología y clínica

- **Transmisión:** aerosoles y contacto con el líquido vesicular. **Altamente contagiosa** (tasa de ataque secundaria domiciliaria > 85 %).
- **Período de incubación:** 10-21 días.
- **Período de contagio:** desde 1-2 días antes del exantema hasta que todas las lesiones están en costra (habitualmente 5-7 días; más prolongado en inmunosuprimidos).
- **Clínica:** pródromo de fiebre y malestar (más marcado en el adulto), seguido de exantema **pruriginoso, centrípeto**, que evoluciona de mácula a pápula, vesícula y costra, y que se caracteriza por la presencia **simultánea de lesiones en distintos estadios** ("cielo estrellado"), con **compromiso del cuero cabelludo y de las mucosas**.

3. Varicela del adulto y complicaciones

La varicela en el adulto es una enfermedad **significativamente más grave que en el niño**, con **mortalidad y tasa de complicaciones varias veces mayores**. Este es el punto de mayor rendimiento clínico del tema.

Complicación	Detalle
Neumonía varicelosa	La complicación más grave del adulto , especialmente en fumadores, embarazadas e inmunosuprimidos. Aparece 3-5 días tras el exantema, con tos, disnea e infiltrados nodulillares difusos. Puede progresar a insuficiencia respiratoria grave . Deja calcificaciones pulmonares residuales
Sobreinfección bacteriana de las lesiones	<i>S. aureus</i> y <i>S. pyogenes</i> : celulitis, absceso, fasciitis necrotizante, síndrome de shock tóxico , bacteriemia. Es la complicación más frecuente
Ataxia cerebelosa aguda	Más frecuente en niños; benigna y autolimitada
Encefalitis	Menos frecuente pero grave
Hepatitis	Elevación de transaminasas, habitualmente leve
Síndrome de Reye	Asociado al uso de ácido acetilsalicílico : contraindicado en niños y adolescentes con varicela o influenza
Trombocitopenia, púrpura fulminante, glomerulonefritis	Infrecuentes

Factores de riesgo de varicela grave: adulto (especialmente > 20 años), **embarazo, inmunosupresión, tabaquismo**, enfermedad pulmonar crónica, tratamiento con corticoides.

4. Diagnóstico de la varicela

- **Es fundamentalmente clínico:** el exantema es característico.
- **PCR del líquido vesicular** cuando se requiere confirmación: es el método de elección (más sensible que el cultivo y la inmunofluorescencia).
- **Serología IgG:** útil para **determinar susceptibilidad** —antes de inmunosuprimir, en el personal de salud, en la embarazada expuesta, en el candidato a trasplante—, **no para el diagnóstico agudo**.
- **Diferencial:** viruela símica (mpox), infección diseminada por VHS, exantemas por enterovirus, rickettsiosis, picaduras, dermatitis herpetiforme, erupción por fármacos.

5. Tratamiento de la varicela

Regla: en el adulto, la varicela SIEMPRE se trata, por el mayor riesgo de complicaciones.

Situación	Tratamiento
Adulto inmunocompetente	Aciclovir 800 mg VO 5 veces al día por 5-7 días, o valaciclovir 1 g VO cada 8 h. Máximo beneficio si se inicia dentro de las 24 horas del exantema
Varicela grave, neumonía varicelosa, encefalitis, inmunosupresión, embarazo con compromiso sistémico	Aciclovir 10 mg/kg IV cada 8 h
Niño sano	Habitualmente sintomático ; se trata si hay factores de riesgo
Sintomático	Antihistamínicos para el prurito, paracetamol para la fiebre. NO usar ácido acetilsalicílico (síndrome de Reye). Evitar antiinflamatorios no esteroideos , por la asociación descrita con infección invasora por <i>S. pyogenes</i>
Sobreinfección bacteriana	Antibiótico con cobertura de <i>S. aureus</i> y <i>S. pyogenes</i> ; umbral bajo para sospechar fascitis necrotizante ante dolor desproporcionado

6. Varicela en el embarazo y varicela neonatal

- La varicela en la embarazada es **más grave**, con **riesgo elevado de neumonía varicelosa** y mortalidad materna aumentada.
- **Síndrome de varicela congénita**: riesgo bajo (aproximadamente 1-2 %) pero grave, cuando la infección materna ocurre **antes de las 20 semanas**: cicatrices cutáneas cicatriciales, hipoplasia de extremidades, alteraciones oculares y del SNC.
- **Varicela neonatal grave**: cuando la madre desarrolla varicela **entre 5 días antes y 2 días después del parto**, el recién nacido recibe el virus sin anticuerpos maternos protectores. **Alta mortalidad**. Requiere **inmunoglobulina específica y aciclovir**.
- **Manejo**: aciclovir a la embarazada con varicela (endovenoso si es grave); **inmunoglobulina específica a la embarazada susceptible expuesta**, lo antes posible; y manejo neonatológico según el momento del parto.
- La **vacuna contra varicela está contraindicada en el embarazo** (es de virus vivo atenuado), y se recomienda evitar el embarazo por un mes tras la vacunación.

7. Profilaxis postexposición de la varicela

Ante un contacto significativo de una persona susceptible (sin antecedente de varicela ni vacunación, o serología IgG negativa):

Población	Medida
Inmunocompetente susceptible	Vacuna contra varicela dentro de los 3-5 días de la exposición: previene o atenúa la enfermedad
Inmunosuprimido, embarazada susceptible, recién nacido de madre con varicela periparto, prematuro	Inmunoglobulina específica anti-VVZ (IGVZ) , lo antes posible y hasta 10 días después de la exposición. Si no está disponible, se ha usado inmunoglobulina endovenosa estándar o profilaxis con aciclovir desde el día 7 al 14 postexposición
Personal de salud susceptible expuesto	Vacunación, y restricción laboral desde el día 8 hasta el día 21 postexposición (28 días si recibió inmunoglobulina), por el riesgo de transmisión durante el período de incubación

Verificar la disponibilidad de la inmunoglobulina específica y el protocolo institucional, que suele requerir gestión anticipada.

8. Herpes zóster: patogenia y factores de riesgo

- **Reactivación del VVZ latente** en un ganglio sensitivo, por **caída de la inmunidad celular específica**.
- **Riesgo a lo largo de la vida**: **aproximadamente 30 %**, y aumenta marcadamente con la edad: más de la mitad de los casos ocurre en mayores de 60 años.

Factores de riesgo:

- **Edad ≥ 50 años** — el factor dominante.
- **Inmunosupresión**: VIH, neoplasia hematológica, trasplante, **corticoides, biológicos** (especialmente **inhibidores de JAK**, que tienen un riesgo particularmente elevado), quimioterapia.
- Estrés, trauma local, comorbilidad, sexo femenino.
- **Un zóster en una persona joven sin causa aparente obliga a solicitar estudio de VIH**, y a considerar otras causas de inmunosupresión.

9. Herpes zóster: clínica

- **Fase prodrómica:** dolor, ardor, prurito o disestesia en el dermatoma, que precede al exantema en 2-3 días (a veces hasta una semana). Es una causa frecuente de diagnósticos erróneos — angina, cólico renal, abdomen agudo, lumbago, glaucoma— cuando el dolor precede a las lesiones.
- **Exantema:** vesículas agrupadas sobre base eritematosa, **unilateral, limitado a uno o dos dermatomas contiguos, que no cruza la línea media**. Evoluciona a costra en 7-10 días y cicatriza en 2-4 semanas.
- **Dermatomas más afectados:** torácicos (más del 50 %), seguidos de la rama oftálmica del trigémino y de los cervicales y lumbares.
- **Dolor:** presente en la mayoría, de intensidad variable, con componente neuropático.
- **Zóster sine herpette:** dolor dermatómico **sin exantema**; diagnóstico difícil, requiere PCR o serología.

10. Formas especiales de zóster

Forma	Descripción y conducta
Herpes zóster oftálmico	Compromiso de la rama oftálmica del trigémino (V1). El signo de Hutchinson —vesículas en la punta o el lado de la nariz, territorio del nervio nasociliar— predice compromiso ocular . Complicaciones: queratitis, uveítis, escleritis, glaucoma, neuritis óptica, necrosis retiniana. Requiere evaluación oftalmológica urgente y tratamiento antiviral sistémico , aunque hayan pasado más de 72 horas
Síndrome de Ramsay Hunt (zóster ótico)	Compromiso del ganglio geniculado: parálisis facial periférica , vesículas en el conducto auditivo externo o el pabellón, dolor ótico, hipoacusia, vértigo, alteración del gusto. Peor pronóstico de recuperación facial que la parálisis de Bell : requiere antiviral más corticoides , iniciados precozmente
Zóster diseminado	> 20 lesiones fuera del dermatoma primario , o compromiso visceral. Ocurre en inmunosuprimidos. Requiere aciclovir endovenoso y precauciones de aerosoles y contacto
Vasculopatía por VVZ	Accidente cerebrovascular en las semanas a meses siguientes a un zóster, especialmente oftálmico, por arteritis de grandes o pequeños vasos. Se diagnostica con angiografía y PCR o anticuerpos anti-VVZ en LCR
Mielitis, meningitis, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré	Complicaciones neurológicas menos frecuentes
Necrosis retiniana aguda	Urgencia oftalmológica que requiere antiviral endovenoso
Zóster multimetamérico o bilateral	Muy sugerente de inmunosupresión: estudiar VIH y neoplasia

11. Diagnóstico del zóster

- Es **clínico** en la presentación típica.
- **PCR del líquido vesicular** cuando hay duda (presentación atípica, inmunosuprimido, zóster sine herpette): es el método de elección, y **distingue VVZ de VHS**.
- **PCR o anticuerpos anti-VVZ en LCR** ante sospecha de compromiso del SNC o vasculopatía.
- La citología de Tzanck **no distingue VVZ de VHS** y está obsoleta.

12. Tratamiento del zóster

Aspecto	Recomendación
Antiviral	Valaciclovir 1 g VO cada 8 h por 7 días , o famciclovir 500 mg cada 8 h, o aciclovir 800 mg 5 veces al día (menos cómodo por la frecuencia y la menor biodisponibilidad)
Ventana terapéutica	Máximo beneficio dentro de las 72 horas del inicio del exantema. Se trata igualmente después de ese plazo si: siguen apareciendo lesiones nuevas, hay compromiso oftálmico o de otro par craneal, hay diseminación, o el paciente está inmunosuprimido
A quién tratar	Todos los adultos ≥ 50 años , todo paciente inmunosuprimido, zóster oftálmico o de otro par craneal, zóster diseminado , dolor moderado a intenso, exantema extenso. En el adulto joven con cuadro leve y localizado el beneficio es menor, pero el tratamiento es razonable

Aspecto	Recomendación
Vía endovenosa	Aciclovir 10 mg/kg IV cada 8 h en: zóster diseminado, compromiso del SNC, necrosis retiniana aguda, inmunosupresión profunda
Analgesia	Escalonada: paracetamol y antiinflamatorios; opioides si el dolor es intenso; gabapentina o pregabalina, amitriptilina o nortriptilina para el componente neuropático. El control adecuado del dolor agudo se asocia a menor riesgo de neuralgia postherpética
Corticoides	No previenen la neuralgia postherpética. Pueden reducir el dolor agudo y acelerar la cicatrización, pero con efectos adversos. Su indicación clara es el síndrome de Ramsay Hunt (asociados al antiviral) y algunos casos de zóster oftálmico bajo supervisión oftalmológica
Cuidado local	Compresas, higiene, cubrir las lesiones para reducir la transmisión. Evitar antivirales tópicos, que no aportan

El antiviral reduce la duración del exantema, el dolor agudo y la eliminación viral. Su efecto sobre la neuralgia postherpética es modesto: lo que realmente la previene es la vacunación.

13. Neuralgia postherpética

- **Definición:** dolor que **persiste más de 90 días** tras la resolución del exantema.
- Es la **complicación más frecuente y más incapacitante del zóster.**
- **Factores de riesgo: edad avanzada** (el más importante: infrecuente antes de los 50 años y muy frecuente después de los 70), **dolor agudo intenso, exantema extenso, pródromo doloroso prolongado**, zóster oftálmico, inmunosupresión.
- **Clínica:** dolor urente, lancinante o eléctrico, con **alodinia** (dolor ante estímulos no dolorosos) e hiperalgesia, que puede durar meses o años y deteriorar gravemente la calidad de vida, el sueño y el ánimo.
- **Tratamiento:**

Línea	Opciones
Primera línea	Gabapentina o pregabalina; antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, nortriptilina — preferir nortriptilina en el adulto mayor por menor carga anticolinérgica); parches de lidocaína al 5 % (especialmente útiles por su perfil de seguridad en el anciano)
Segunda línea	Parches de capsaicina al 8 % (aplicación por personal entrenado); opioides como tramadol u oxycodona, con precaución
Refractaria	Derivación a unidad del dolor: bloqueos, estimulación, terapias intervencionales

- La mejor estrategia frente a la neuralgia postherpética es la **prevención mediante la vacunación.**

14. Zóster en el inmunosuprimido

- **Mayor riesgo, mayor extensión, mayor frecuencia de diseminación y de compromiso visceral.**
- **Zóster multimetamérico, recurrente o diseminado** obliga a **estudiar inmunosupresión, incluido VIH.**
- **Tratamiento:** antiviral endovenoso en cuadros graves o diseminados; oral en cuadros localizados con inmunosupresión leve, con seguimiento estrecho.
- **Precauciones de aerosoles y contacto** en el zóster diseminado o en el inmunosuprimido.
- **Profilaxis:** aciclovir o valaciclovir en receptores de trasplante hematopoyético y en otras situaciones de inmunosupresión profunda.
- **SIRI:** el zóster puede aparecer en las semanas siguientes al inicio de la terapia antirretroviral en personas con VIH, como manifestación de reconstitución inmune.
- La **vacuna recombinante adyuvada (no viva)** es la **indicada en inmunosuprimidos**; la vacuna viva atenuada está contraindicada.

15. Aislamiento y control de infecciones

Situación	Precauciones
Varicela	Aerosoles + contacto , hasta que todas las lesiones estén en costra
Zóster diseminado	Aerosoles + contacto , hasta que todas las lesiones estén en costra

Situación	Precauciones
Zóster localizado en inmunocompetente	Contacto , con las lesiones cubiertas ; no requiere habitación con presión negativa
Zóster localizado en inmunosuprimido	Aerosoles + contacto (por el riesgo de diseminación)
Personal de salud	Debe estar inmune (antecedente documentado, vacunación o serología). El personal susceptible expuesto se restringe del día 8 al 21 postexposición
Contacto de un paciente con zóster	Una persona susceptible puede desarrollar varicela , no zóster

16. Vacunación

Vacuna contra varicela (virus vivo atenuado):

- Indicada en la infancia según el calendario, y en **adultos susceptibles**, especialmente **personal de salud**, mujeres en edad fértil no embarazadas, personas en contacto con inmunosuprimidos, y candidatos a inmunosupresión (administrada **antes** de iniciarla).
- Contraindicada** en el embarazo y en la inmunosupresión significativa.
- Verificar el calendario y las indicaciones vigentes del Programa Nacional de Inmunizaciones.**

Vacuna contra herpes zóster:

Tipo	Características
Recombinante adyuvada (subunidad, no viva)	Eficacia superior al 90 % frente al zóster y a la neuralgia postherpética en los ensayos ZOE-50 y ZOE-70 , con eficacia mantenida en mayores de 70 años y duración prolongada . Se administra en 2 dosis . Puede usarse en inmunosuprimidos , en quienes también ha mostrado eficacia. Reactogenicidad local y sistémica frecuente pero autolimitada
Viva atenuada (formulación antigua de alta potencia)	Eficacia menor (~50 %) y decreciente con la edad y el tiempo. Contraindicada en inmunosuprimidos . Ha sido reemplazada donde la recombinante está disponible

- Indicación general:** adultos ≥ 50 años, y personas $\geq 18-19$ años con **inmunosupresión** o riesgo aumentado, según las recomendaciones vigentes.
- Se vacuna también a quienes ya tuvieron zóster**, una vez resuelto el episodio agudo.
- La disponibilidad de la vacuna recombinante en Chile y su inclusión en el Programa Nacional de Inmunizaciones deben verificarse**, ya que las recomendaciones han ido cambiando.

17. Errores frecuentes

- **No tratar la varicela en el adulto:** siempre se trata, por el riesgo de neumonía varicelosa. - **Usar ácido acetilsalicílico** en un niño o adolescente con varicela (síndrome de Reye). - **No sospechar sobreinfección invasora por *S. pyogenes*** ante dolor desproporcionado en una varicela. - **No derivar a oftalmología** un zóster oftálmico, especialmente con signo de Hutchinson. - **No tratar un zóster oftálmico** por haber pasado las 72 horas: se trata igual. - **No usar corticoides en el Ramsay Hunt**, donde sí están indicados junto al antiviral. - **Esperar que los corticoides prevengan la neuralgia postherpética:** no lo hacen. - **No estudiar VIH** ante un zóster en una persona joven, multimetamérico o recurrente. - **Confundir el pródromo doloroso** con angina, cólico renal o abdomen agudo, y no reevaluar. - **Usar la vacuna viva atenuada en un inmunosuprimido.** - **No vacunar antes de iniciar una inmunosupresión programada.** - **Aislar mal:** recordar que la varicela y el zóster diseminado requieren **aerosoles y contacto**.

18. Perlas de alto rendimiento

- Un paciente con zóster puede transmitir varicela** (no zóster) a un susceptible.
- La varicela del adulto siempre se trata;** su complicación más grave es la **neumonía varicelosa**, sobre todo en fumadores y embarazadas.
- Lesiones en distintos estadios simultáneamente** es el sello de la varicela.
- No dar ácido acetilsalicílico** (Reye) ni, en lo posible, antiinflamatorios no esteroideos (infección invasora por *S. pyogenes*).
- Zóster: valaciclovir 1 g cada 8 h por 7 días, idealmente dentro de las 72 horas.**
- Se trata más allá de las 72 horas si hay lesiones nuevas, compromiso oftálmico, diseminación o inmunosupresión.**

- **Signo de Hutchinson** (vesículas en la punta de la nariz) predice compromiso ocular: **derivación urgente**.
- **Ramsay Hunt: antiviral MÁS corticoides**, con peor pronóstico facial que la parálisis de Bell.
- **Los corticoides no previenen la neuralgia postherpética**; la **vacuna sí**.
- **Neuralgia postherpética: gabapentina, pregabalina, tricíclicos y parches de lidocaína**.
- **Zóster en un joven, multimetamérico o recurrente -> estudiar VIH**.
- **La vacuna recombinante adyuvada tiene eficacia > 90 % y puede usarse en inmunosuprimidos**; la viva atenuada, no.
- **Varicela y zóster diseminado: aerosoles más contacto, hasta que todas las lesiones estén en costra**.

19. Bibliografía esencial

- Gnann JW, Whitley RJ. Herpes zoster. *N Engl J Med*. 2002;347:340-6.
- Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults (ZOE-50). *N Engl J Med*. 2015;372:2087-96.
- Cunningham AL, Lal H, Kovac M, et al. Efficacy of the herpes zoster subunit vaccine in adults 70 years of age or older (ZOE-70). *N Engl J Med*. 2016;375:1019-32.
- Dooling KL, Guo A, Patel M, et al. Recommendations of the ACIP for use of herpes zoster vaccines. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2018;67:103-8.
- Marin M, Güris D, Chaves SS, et al. Prevention of varicella: recommendations of the ACIP. *MMWR Recomm Rep*. 2007;56(RR-4):1-40.
- Johnson RW, Rice AS. Postherpetic neuralgia. *N Engl J Med*. 2014;371:1526-33.
- Nagel MA, Gilden D. The relationship between herpes zoster and stroke. *Curr Neurol Neurosci Rep*. 2015;15:16.
- Ministerio de Salud de Chile. Programa Nacional de Inmunizaciones: calendario y recomendaciones vigentes. Verificar en www.minsal.cl.